

TEMA 10.10 • REUMATOLOGÍA

Artritis Reumatoide vs Artrosis

PERFIL EUNACOM 1.05.1.002
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Diferenciar entre la **Artritis Reumatoide** (AR) y la **Artrosis** (también llamada osteoartritis) es fundamental en la práctica clínica y una pregunta recurrente en el examen EUNACOM. Aunque ambas afectan las articulaciones, su fisiopatología, presentación clínica y manejo son radicalmente distintos.

Conceptos Fundamentales

La diferencia principal radica en la presencia o ausencia de **inflamación verdadera** (sinovitis):

Artritis Reumatoide: Es una enfermedad autoinmune sistémica que produce **artritis** real. Esto implica signos inflamatorios: derrame articular, eritema, calor local y aumento de volumen blando. **Artrosis:** Es una enfermedad degenerativa del cartílago. Produce **artralgias** (dolor articular) y puede presentar crujidos o deformidad ósea, pero habitualmente **no presenta signos inflamatorios** sistémicos ni locales persistentes (aunque puede haber derrame leve por sobreuso, especialmente en rodillas).

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: En la AR, el tejido diana es la **sinovial**, la cual se inflama y prolifera (pannus) destruyendo el hueso y cartílago. En la artrosis, el problema primario es el desgaste del **cartilago hialino** con posterior reacción del hueso subcondral (osteofitos).

Comparativa Clínica: AR vs. Artrosis

TABLA 10.10.1: CARACTERÍSTICA VS ARTRITIS REUMATOIDE (AR)		
CARACTERÍSTICA	ARTRITIS REUMATOIDE (AR)	ARTROSIS (OSTEOARTRITIS)
Tipo de dolor	Inflamatorio (mejora con el movimiento)	Mecánico (empeora con el movimiento)
Signos inflamatorios	Presentes (calor, rubor, edema blando)	Ausentes (edema duro/ óseo, sin calor)
Rigidez matinal	Prolongada (> 30-60 minutos)	Breve (< 30 minutos, suele ser de 5-10 min)
Compromiso Sistémico	Sí (fiebre, baja de peso, astenia)	No (localizado a la articulación)
Distribución	Simétrica, pequeñas articulaciones	Asimétrica o simétrica, grandes cargas y manos

Distribución Articular en las Manos

Este es el punto más preguntado para diferenciar ambas patologías mediante la inspección o la anamnesis.

- **Artritis Reumatoide:**
 - **Interfalángicas Proximales (IFP).**
 - **Metacarpofalángicas (MCF):** Casi siempre afectadas.
 - **Muñecas:** Compromiso muy frecuente.
 - **Nota:** Respeta clásicamente las interfalángicas distales.
- 2. **Artrosis: Interfalángicas Distales (IFD):** Es su sello característico en las manos. **Interfalángicas Proximales (IFP).** **Base del pulgar (Trapecio-metacarpiana):** Conocida como **rizartrosis**. **Nota:** Respeta clásicamente las metacarpofalángicas y las muñecas.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si un paciente presenta compromiso de las **Interfalángicas Distales (IFD)** con signos de artritis (inflamación), piensa en **Artritis Psoriásica** o Artritis Reactiva, ya que la AR no suele afectarlas y la Artrosis no produce inflamación activa.

Deformidades Típicas

Con el tiempo, ambas enfermedades generan cambios estructurales visibles que permiten el diagnóstico clínico:

En la Artrosis

Nódulos de Heberden: Engrosamiento óseo en las interfalángicas **distales (IFD)**. **Nódulos de Bouchard:** Engrosamiento óseo en las interfalángicas **proximales (IFP)**.

En la Artritis Reumatoide

Ráfaga Cubital: Desviación de los dedos hacia el lado del cúbito (meñique) debido a la destrucción de las MCF. **Dedos en Cuello de Cisne:** Hiperextensión de la IFP y flexión de la IFD. **Dedos en Ojal (Boutonnière) o "en sastre":** Flexión de la IFP e hiperextensión de la IFD.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

No confundir los nódulos de Bouchard (Artrosis - IFP) con el aumento de volumen sinovítico de la AR en las mismas articulaciones. El nódulo de la artrosis es **duro y óseo**, mientras que en la AR el aumento es **blando y fluctuante**.

Rigidez Matinal

La duración de la rigidez al despertar es un marcador clave de inflamación:

En la AR: Es muy marcada y prolongada. El paciente siente las manos "trabadas" o "tiesas" por más de **30 a 60 minutos**. Es común que mejore recién a media mañana tras realizar actividades. **En la Artrosis:** Puede existir rigidez tras el reposo prolongado, pero es **fugaz**. Típicamente dura menos de 30 minutos (frecuentemente 5 a 10 minutos) y cede rápidamente con el movimiento inicial.

Resumen de Diagnóstico por Imagen

Artrosis: Veremos disminución asimétrica del espacio articular, **osteofitos**, esclerosis subcondral y geodas (quistes óseos). * **Artritis Reumatoide:** Veremos osteopenia yuxtaarticular (en banda), disminución simétrica del espacio articular y **erosiones óseas** (signo precoz de daño irreversible).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Para el EUNACOM: Paciente mujer, joven/mediana edad, con dolor simétrico en muñecas y MCF, rigidez > 1 hora = **Artritis Reumatoide**. Paciente adulto mayor, dolor en IFD que empeora al usar las manos, nódulos duros = **Artrosis**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente con dolor en articulaciones de las manos, sin signos inflamatorios, con nódulos duros en IFD. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Artritis Reumatoide vs Artrosis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La diferencia principal es que la AR tiene artritis (inflamación) y la artrosis tiene solo artralgiás (dolor sin inflamación)
- AR afecta IFP, MCF y muñecas; artrosis afecta IFP e IFD
- Deformaciones de AR: ráfaga cubital, cuello de cisne, boutonnière; deformaciones de artrosis: nódulos de Heberden y Bouchard
- Rigidez matinal >30 min (AR) vs <30 min (artrosis)
- No pedir marcadores inmunológicos a una artrosis ni pasar por alto una AR

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ARTRITIS REUMATOIDE VS ARTROSIS)**PREGUNTA 1**

Paciente con dolor en articulaciones de las manos, sin signos inflamatorios, con nódulos duros en IFD. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Artritis reumatoide
- B)** Artrosis
- C)** Artritis psoriásica
- D)** Gota tofácea
- E)** Lupus eritematoso sistémico

PREGUNTA 2

¿Cuál de los siguientes es el dato clínico más importante para diferenciar artritis reumatoide de artrosis?

- A)** La edad del paciente
- B)** La presencia o ausencia de artritis (signos inflamatorios articulares)
- C)** El resultado del factor reumatoide
- D)** La presencia de rigidez matinal
- E)** La radiografía de manos

PREGUNTA 3

Paciente con poliartritis de MCF y muñecas, rigidez matinal de 2 horas y desviación de los dedos hacia cubital. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A)** Artrosis de manos
- B)** Artritis reumatoide
- C)** Fibromialgia
- D)** Artritis reactiva
- E)** Condrocálcinosis

RESUMEN: ARTRITIS REUMATOIDE VS ARTROSIS

Esta clase diferencia la artritis reumatoide de la artrosis para evitar pedir exámenes innecesarios a la artrosis o dejar pasar una artritis reumatoide. La diferencia principal es que la AR viene con artritis (derrame articular, eritema, aumento de volumen) mientras que la artrosis viene sin artritis, solo con artralgiás. Las articulaciones afectadas difieren: AR afecta IFP, MCF y muñecas; artrosis afecta IFP e IFD (no MCF ni muñecas). Las deformaciones tardías son distintas: AR produce ráfaga cubital, dedos en cuello de cisne y dedos en boutonnière; artrosis produce nódulos de Heberden (IFD) y Bouchard (IFP). La rigidez matinal en AR es prolongada (más de 30 minutos, habitualmente más de 1 hora), mientras que en artrosis es breve (5-10 minutos, siempre menos de 30 minutos). Lo más importante para distinguirlas es la presencia o ausencia de artritis.